

ΟΞΕΙΑ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ & ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑΣ

Γενικά: Ως οξεία βρογχίτιδα ή έξαρση χρόνιας βρογχίτιδας (*AECB*), καλείται κάθε οξεία αυτοπεριοριζόμενη φλεγμονή της τραχείας ή του τραχειοβρογχικού δένδρου (ICD-10: J20).

Η παρόξυνση χρόνιας βρογχίτιδας απαιτεί την παρουσία και των **3 κριτηρίων Anthonisen**, δηλαδή **δύσπνοια, παραγωγικό βήχα**, καθώς και **μεταβολή του χαρακτήρα των πτυέλων σε πυώδη**. Επί υπάρξεως δύο κριτηρίων Anthonisen, το ένα υποχρεωτικά πρέπει να αφορά στην παρουσία πυωδών πτυέλων, ώστε ο ασθενής να ωφεληθεί το βέλτιστο δυνατό από την εφαρμογή κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αίτια: Συνήθεις μικροοργανισμοί, ενοχοποιούμενοι για παροξύνσεις χρόνιας βρογχίτιδας, είναι: *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Streptococcus pneumoniae* και *Moraxella catarrhalis*, καθώς και ορισμένα άτυπα βακτήρια (*Chlamydia pneumoniae*) και ιοί (*Rhinovirus*, *Adenovirus*, *Coronavirus*, *Influenza type B*, *RSV* και *h-MPV*, κ.λπ.). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτιολογία της οξείας βρογχίτιδας παραμένει αβέβαιη. Παράγοντες κινδύνου για συγκεκριμένα παθογόνα, αποτελούν: η παρουσία επιδημίας στην κοινότητα, η χρονική περίοδος εμφάνισης της νόσου, η διενέργεια ή όχι εμβολιασμού για τη γρίπη, ο πληθυσμός που νοσεί, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η συννοσηρότητα, κ.ά.

Ιστορικό & κλινική εικόνα: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας και υψηλού κινδύνου για πιθανές επιπλοκές λόγω προϋπάρχουσας νοσηρότητας (*ΑΥ/ΣΝ, ΣΔ, ΧΑΠ, άσθμα, ΧΝΑ, ηπατική νόσος, ΓΟΠΝ, νευρομυϊκή νόσος, ανοσοκαταστολή, κ.ά.*).

- ▶ Ο ασθενής εμφανίζεται με δύσπνοια ή με επίταση προϋπάρχουσας δύσπνοιας και ενίοτε με ταχύπνοια. Οι ασθενείς με ιστορικό ΧΑΠ παρουσιάζουν – εφόσον προσβληθούν από οξεία βρογχίτιδα – επίταση των χρονίων συμπτωμάτων της νόσου. Μπορεί να εμφανιστεί σημαντική μείωση της FEV₁ στο 40-50% των ασθενών με AECB, καθώς και βρογχική υπεραντιδραστικότητα με δοκιμασίες πρόκλησης, που βελτιώνονται σε 4-6 εβδομάδες.
- ▶ Βήχας, αρχικά ξηρός, για 3-5 ημέρες και στη συνέχεια παραγωγικός, με βλεννώδη ή/και βλεννοπυώδη απόχρεμψη. Ο βήχας έχει συνήθως διάρκεια μεγαλύτερη των 5-7 ημερών, ενώ μπορεί να διαρκέσει ως 2-3 εβδομάδες. Η παρουσία μόνο του βήχα, ως προεξάρχον σύμπτωμα, δεν αρκεί όμως για να τεθεί η διάγνωση της οξείας βρογχίτιδος.
- ▶ Συνήθως, κατά την ακρόαση του θώρακα μπορεί να μην ακούσουμε κάτι παθογνωμονικό ή μπορεί να εντοπίσουμε ρεγχάζοντες ρόγχους με το χαρακτηριστικό «βράσιμο».
- ▶ Ο πυρετός είναι λιγότερο συχνός και μπορεί να υπάρχει δεκατική πυρετική κίνηση.

Διαφορική διάγνωση: Περιλαμβάνει νοσήματα, όπως: οξεία φλεγμονή μικρών αεραγωγών (*άσθμα ή βρογχιολίτιδα*), κοινό κρυολόγημα, πνευμονία κοινότητας, φυματίωση, ΓΟΠΝ, βρογχεκτασίες, κοκκύτης, βήχας από τη λήψη α-MEA, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, διάμεσα πνευμονικά νοσήματα (*σαρκοείδωση, Ι.Π. ίνωση, κ.λπ.*), πνευμονική εμβολή, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (*ΑΠ, σφύξεις, RR, SpO₂ με παλμική οξυμετρία και θερμοκρασία*). Αν έχουμε την δυνατότητα, διενεργούμε γενική εξέταση αίματος και ελέγχουμε τους δείκτες φλεγμονής (*λευκοκυττάρωση με αύξηση των ουδετεροφίλων και αριστερή στροφή, αύξηση CRP και TKE*) και διενεργούμε ακτινογραφία θώρακος (F/P).
2. Εκτελούμε - *εφόσον κριθεί απαραίτητο* - βρογχοδιαστολή με νεφελοποίηση, χορηγώντας 1 amp. Berovent και 1 amp. Pulmicort, με O₂ στα 4-6 lt/min, για την ανακούφιση των οξέων συμπτωμάτων του ασθενούς. Σε περίπτωση υποψίας λοίμωξης από Coronavirus SARS-CoV2 (νόσος Covid-19) ή άλλης λοιμώδους μεταδοτικής με σταγονίδια νόσου, η διενέργεια νεφελοποίησης αντενδείκνυται αυστηρά (*παρά μόνο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για Covid-19*), για την αποφυγή διασποράς αερολύματος στον χώρο του ιατρείου.



3. Στην οξεία βρογχίτιδα δεν απαιτείται αντιβιοτική θεραπεία. Αλλά, εφόσον σπανίως χρειαστεί, χορηγείται σε ασθενείς με προϋπάρχουσες παθήσεις του αναπνευστικού και βλεννοπυώδη απόχρεμψη. Στη θεραπευτική αγωγή πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν η αντιμικροβιακή αγωγή που πιθανώς έλαβε ο ασθενής, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τους τελευταίους 3 μήνες, ούτως ώστε με βάση τις επιλογές που αναφέρονται ο ασθενής να λάβει αντιβιοτική θεραπεία από διαφορετική ομάδα αντιβιοτικών που δεν συμπίπτει με αυτή που είχε ήδη λάβει, ώστε τελικά να υπάρξει άμεση και ικανοποιητική ανταπόκριση. Εφόσον, κατά το πρόσφατο παρελθόν δεν έχει προηγηθεί χορήγηση αντιβιοτικών, τότε χορηγείται εμπειρικά, ως 1^η επιλογή, μία Μακρολίδη (*Κλαριθρομυκίνη* ή *Αζίθρομυκίνη*):

- ✓ **Klaricid** ή **Claripen** tab. 500 mg, 1x2 (per os), για 10 ημέρες, ή
- ✓ **Zithromax** tab. 250 mg, 2x1 ή **Azirox** tab. 500 mg, 1x1 (po), για 3 ημέρες.

Επί κλινικής αποτυχίας ή επί αντένδειξης της 1^{ης} επιλογής αντιβιοτικών, χορηγούμε:

- ✓ **Amoxi/Clav** (*Augmentin*) tab. 625 mg, 1x3 (po), για 7-10 ημέρες ή
- ✓ **Δοξυκυκλίνη** (*Vibramycin*) tab. 100 mg, 1x2 (po), για 7-10 ημέρες ή
- ✓ **Κεφακλόρη** (*Ceclor MR*) tab. 750 mg, 1x2 ή 1x3 (po), για 7-10 ημέρες ή
- ✓ **Κεφουροξίμη** (*Zinadol/Nelabocin*) tab. 500 mg, 1x2 (po), για 7-10 ημέρες.

4. Σε ασθενείς με ΧΑΠ, που παρουσιάζονται στο ΤΕΠ με παρόξυνση χρόνιας βρογχίτιδας και εμφανίζουν έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου, όπως: η FEV₁ < 50% (στη σταθερή κατάσταση), περισσότερες από 4 εξάρσεις το χρόνο, καρδιοπάθεια, ανάγκη για οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον, χρόνια per os λήψη κορτικοστεροειδών, ανοσοκαταστολή και χρήση αντιβιοτικών το προηγούμενο τρίμηνο, τότε μπορούμε να χορηγήσουμε:

- **Amoxi/Clav** (*Augmentin/Fugentin*) tab. 1 gr, 1x2 (po), για 10 ημέρες, ή
- **Κεφντιτορένη** (*Spectracef*) tab. 400 mg, 1x2 (po), για 10-14 ημέρες ή
- **Μοξιφλοξασίνη** (*Avelox/Octegra*) tab. 400 mg, 1x1 (po), για 10 ημέρες ή
- **Λεβοφλοξασίνη** (*Tavanic/Envoxil*) tab. 500 mg, 1x1 ή 1x2 (po), για 10 ημέρες.

5. Σε περιπτώσεις επιδημίας γρίπης (A & B), τα περισσότερα στελέχη της πανδημίας H₁N₁ και H₃N₂ αντιμετωπίζονται με αναστολείς της νευραμινιδάσης. Για να υπάρξει κλινικό όφελος από τη χορήγηση αντι-ικής αγωγής, αυτή πρέπει να χορηγηθεί εντός 48 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων· αν και πλέον χορηγείται ανά πάσα στιγμή κατά την πορεία βαριάς γριπώδους συνδρομής σε παιδιά και σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου.

- **Οσελταμιβίρη** (*Tamiflu*) tab. 75 mg, 1x2 (po), για 5 ημέρες ή
- **Ζαναμιβίρη** (*Relenza*) inh. pd. 5 mg/dose, 2 εισπνοές x2, για 5 ημέρες.

6. Επί αποτυχίας της δοθείσας αντιβιοτικής αγωγής και επί παραμονής ή/και επίτασης των συμπτωμάτων συνιστάται καλλιέργεια πτυέλων με αντιβιογράμμα, καθώς και διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος, που μολονότι μπορεί να αποβεί αρνητική, κρίνεται απαραίτητη για τη διερεύνηση ενός βήχα που επιμένει για διάστημα μεγαλύτερο των 4-6 εβδομάδων.

7. Χορηγούμε (με αμφίβολη αποτελεσματικότητα) βλεννολυτικά per os, για 7-10 ημέρες.

- ▶ Sachs. **Trebon-N** 600 mg ή tab. **Vlenolys** 600 mg, 1x1 (po), κάθε μεσημέρι ή
- ▶ Syr. **Mucosolvan** 30mg/5 ml ή **Bisolvon** 8mg/5 ml, 1 κουταλιά σούπας x2 ή x3.

8. Οι περισσότεροι ασθενείς με οξεία βρογχίτιδα παρουσιάζονται στο ΤΕΠ με συμπτώματα κοινού κρυολογήματος κι ανταποκρίνονται άμεσα και ικανοποιητικά στη συμπτωματική φαρμακευτική αγωγή (π.χ. ασπιρίνη, παρακεταμόλη, ρινικά αποσυμφορητικά εκνεφώματα, καταπραϋντικά για τον επίμονο βήχα και τον πονόλαιμο, εισπνεόμενα SABA/SAMA, κ.ά.).

- Δεν συνιστάται, σε καμία περίπτωση, η προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών (ακόμα και σε ασθενείς με πνευμονοπάθεια και σοβαρή συννοσηρότητα) κατά τους χειμερινούς μήνες.
- Προτρέπουμε τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια βρογχίτιδα να κάνουν το ετήσιο αντιγριπικό εμβόλιο (*Vaxigrip/Fluarix* κ.ά.), να ακολουθούν το πρόγραμμα εμβολιασμού για τον Πνευμονιόκοκκο (*Prevenar-13 & Pneumona*) και τον RSV (*Arexny*) και να εμβολιαστούν πλήρως για την Covid-19.
- Επί διάγνωσης λοίμωξης Covid-19, καταγράφουμε το περιστατικό στον ΕΟΔΥ. Επί ιστορικού σοβαρής χρόνιας πνευμονικής ή καρδιακής νόσου συστήνεται η χορήγηση κατ' οίκον του αντι-ικού (*Raxlovid*) για 5 ημέρες ή επί ενδείξεων η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.